

ANATOMIA HUMANA

6ª Edição

MARTINI · TIMMONS · TALLITSCH



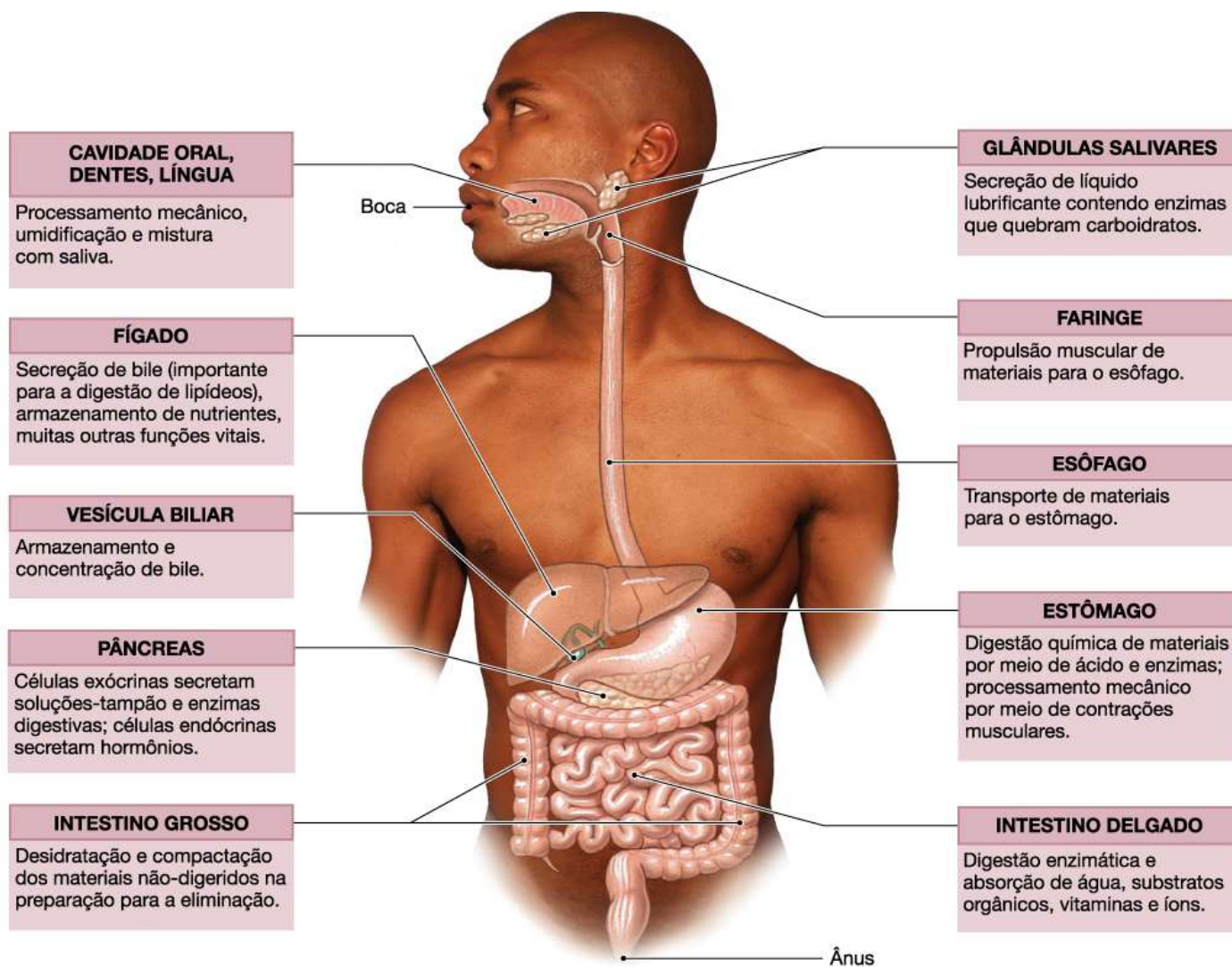
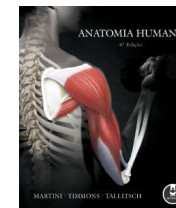
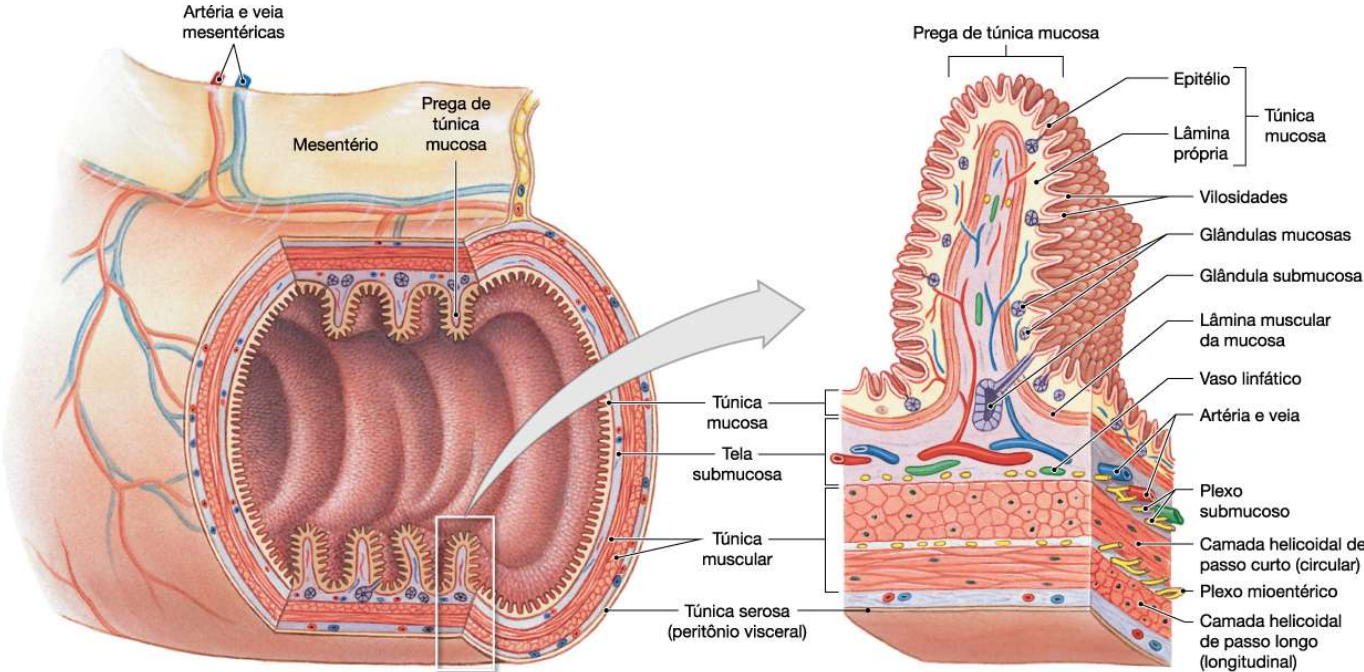
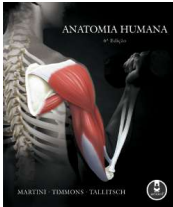
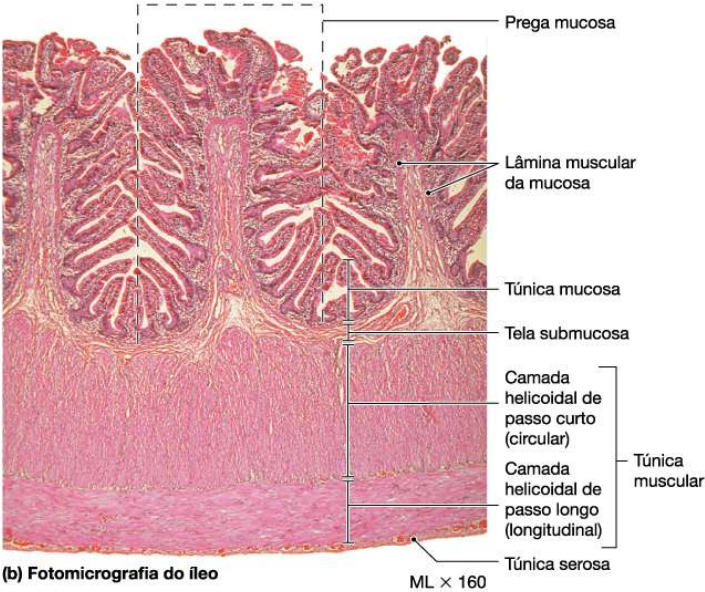


Figura 25.1 Componentes do trato digestório.

Esta figura apresenta as principais regiões e os órgãos acessórios do trato digestório, bem como suas funções primordiais.

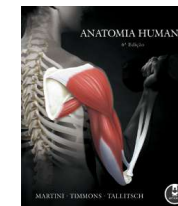


(a) Organização histológica do trato digestório

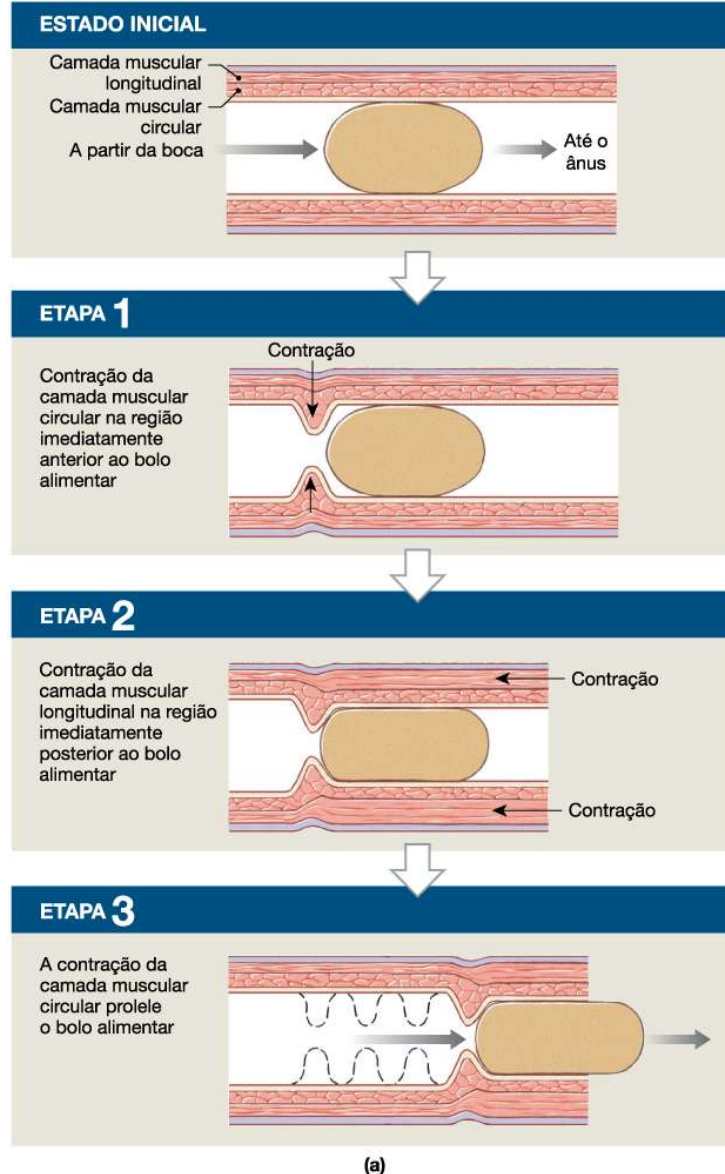


(b) Fotomicrografia do íleo

Figura 25.2 Estrutura histológica do trato digestório.
(a) Vista tridimensional da organização histológica do tubo digestório em geral. (b) Fotomicrografia do íleo, mostrando aspectos da organização histológica do intestino delgado.



Peristalse



Segmentação

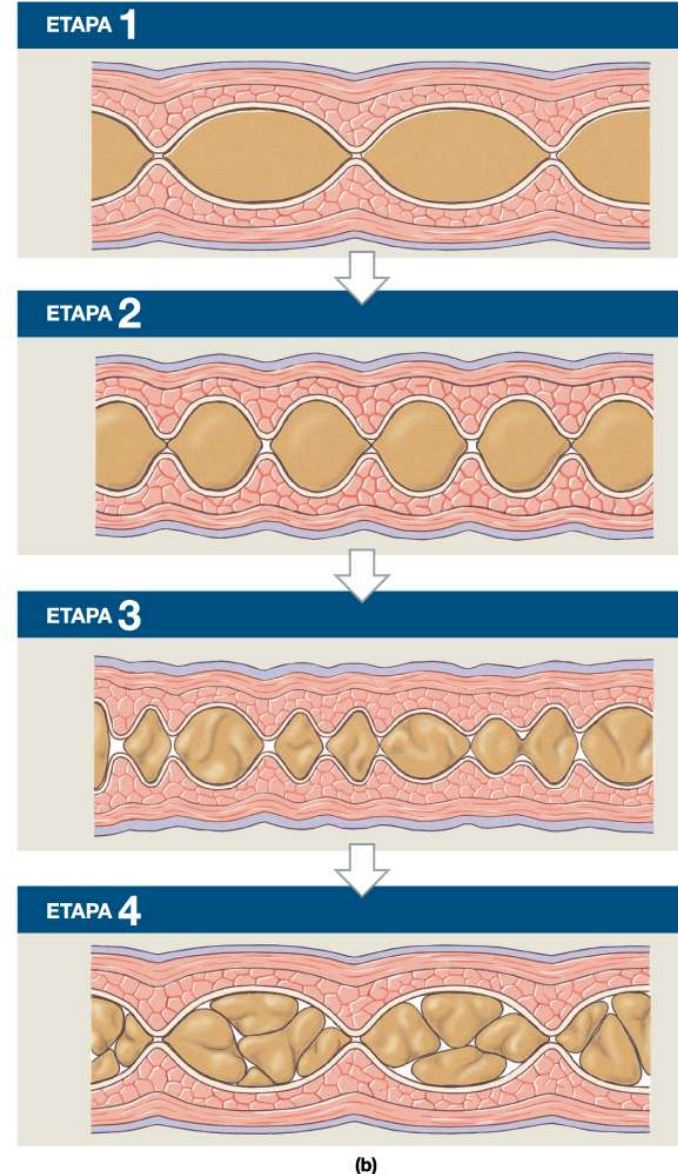


Figura 25.3 Peristalse e segmentação.

(a) A peristalse propõe materiais ao longo da extensão do trato digestório por meio de contrações coordenadas das camadas musculares circular e longitudinal. (b) Os movimentos de segmentação envolvem principalmente a camada muscular circular. Estas atividades misturam e homogeneizam o conteúdo do trato digestório, mas não produzem movimento de rede em uma direção específica.

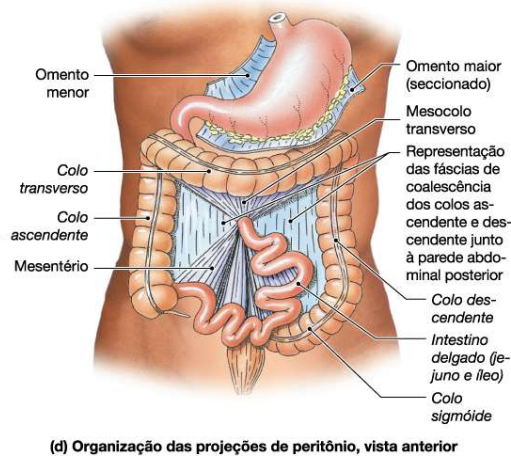
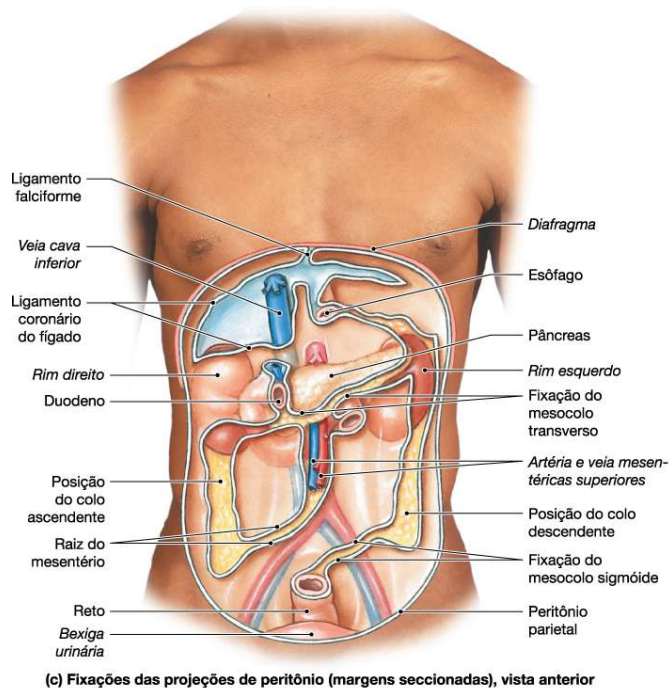
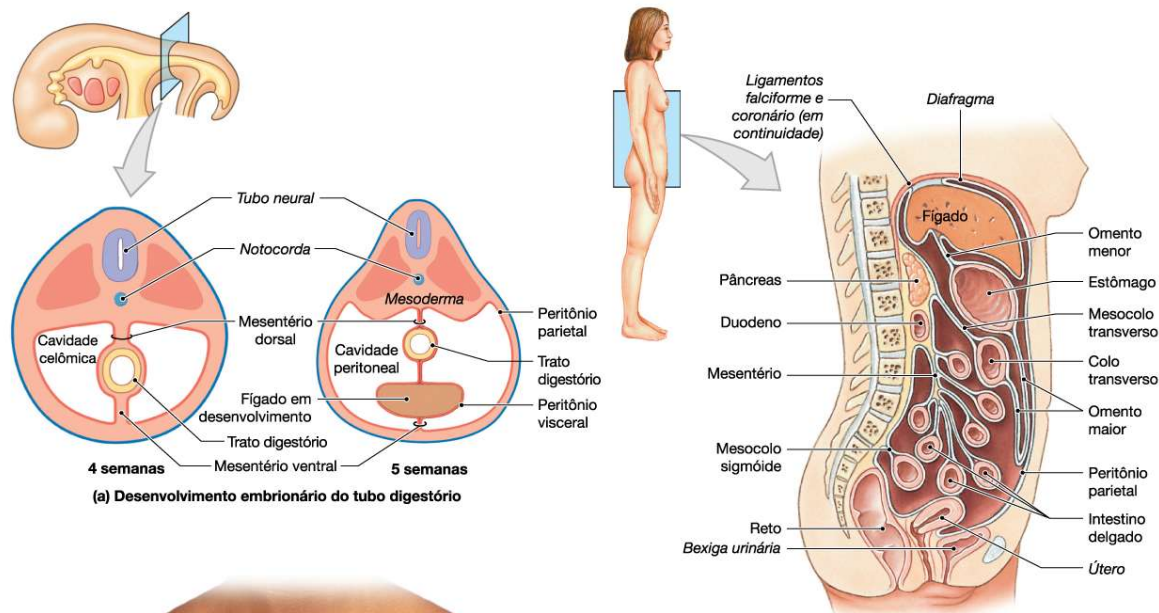
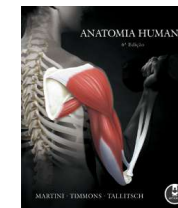


Figura 25.4 Projeções de peritônio.

(a) Vista diagramática de estágio precoce de desenvolvimento embrionário, com os mesentérios primitivos dorsal e ventral sustentando o trato digestório (esquerda). Um estágio imediatamente posterior, mostrando o desenvolvimento do fígado entre as lâminas do mesentério ventral (direita). (Para mais informações, consulte o *Resumo de Embriologia do Capítulo 28*.) (b) Projeções de peritônio na cavidade abdominopélvica, vistas em uma representação de uma seção sagital. (c) Vista anterior de cavidade peritoneal vazia, mostrando as fixações das projeções de peritônio e das vísceras à parede posterior da cavidade abdominal. (d) A organização das projeções de peritônio no adulto. Esta é uma vista estilizada; o comprimento do intestino delgado foi muito reduzido.

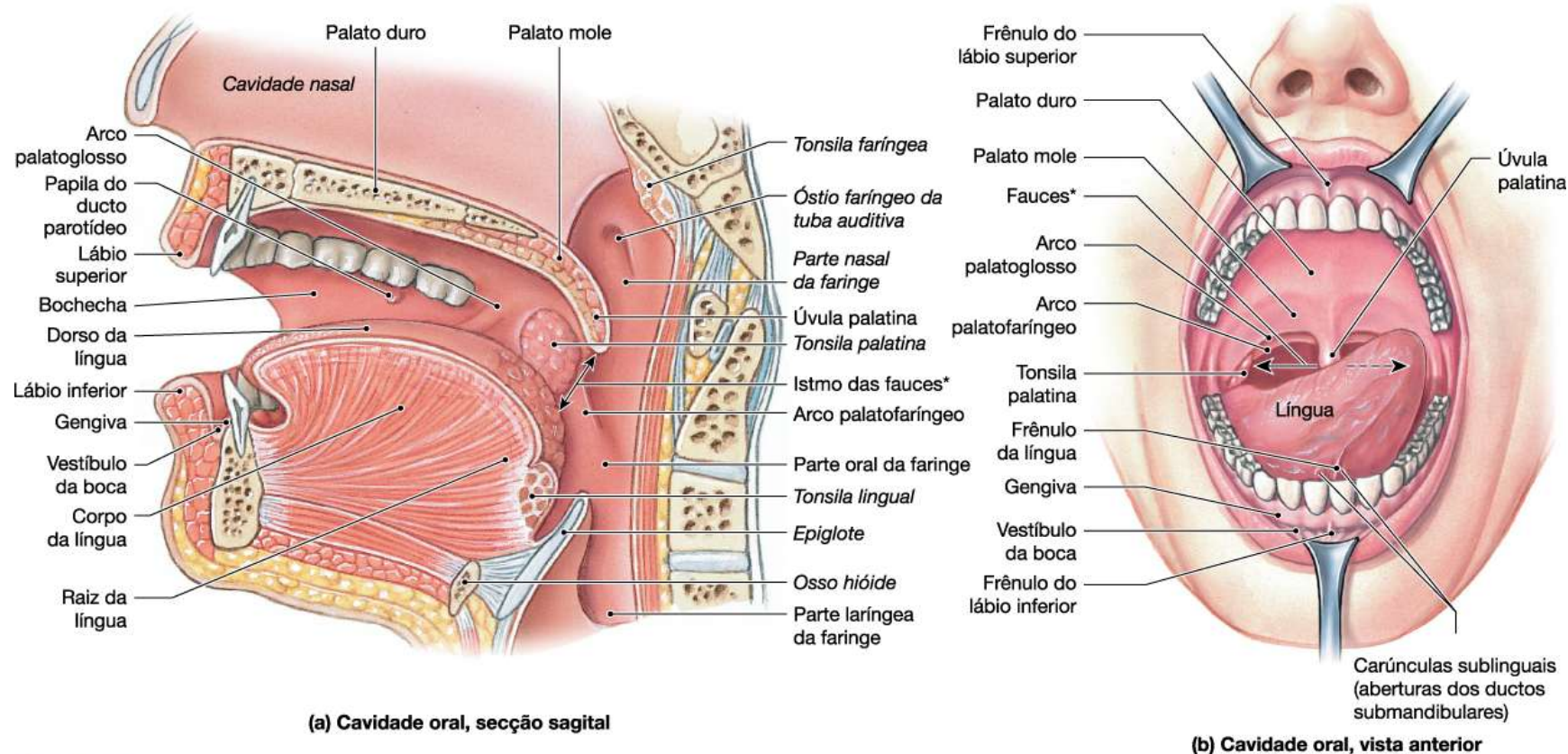
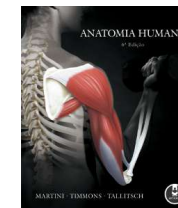


Figura 25.5 Cavidade oral.

(a) Cavidade oral vista em secção sagital. **(b)** Vista anterior da cavidade oral (boca aberta).

* N. de R.T. Fauces (“goela”) é o termo que se refere à região entre a cavidade oral e a faringe; istmo das fauces é a comunicação entre ambos os órgãos.

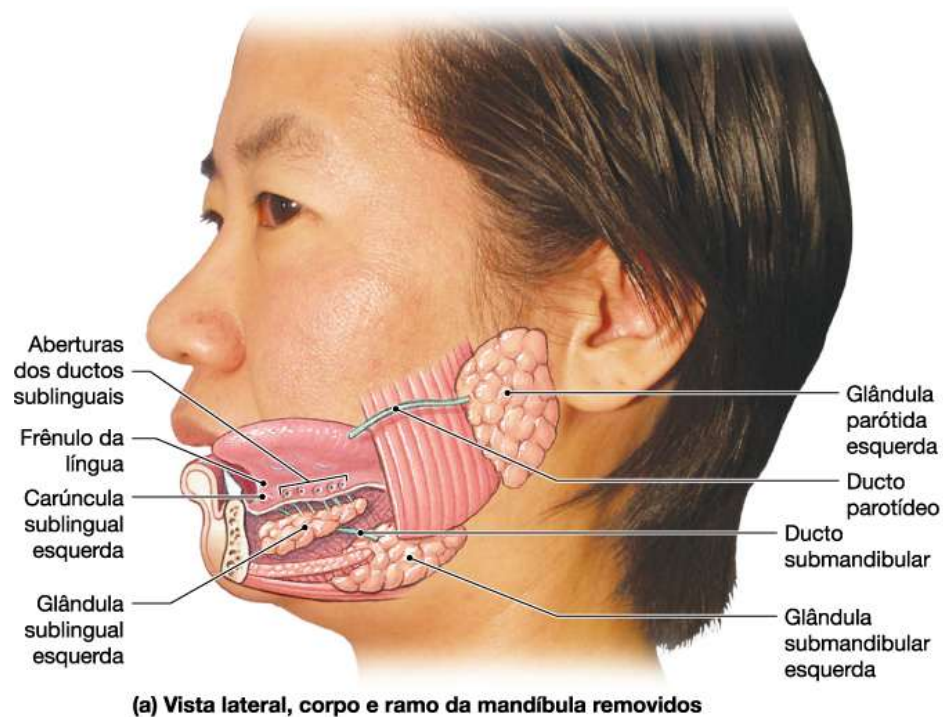
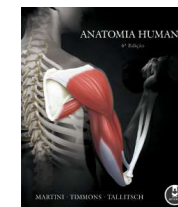
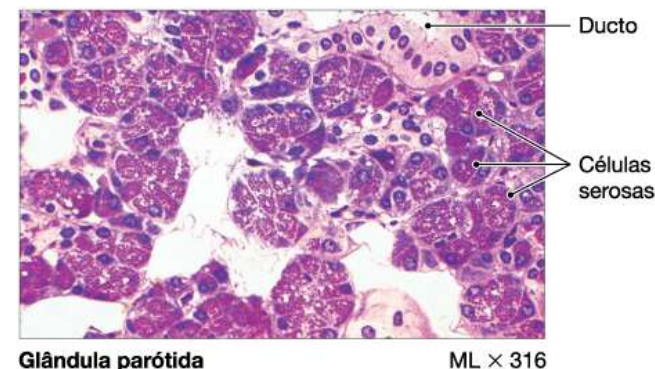
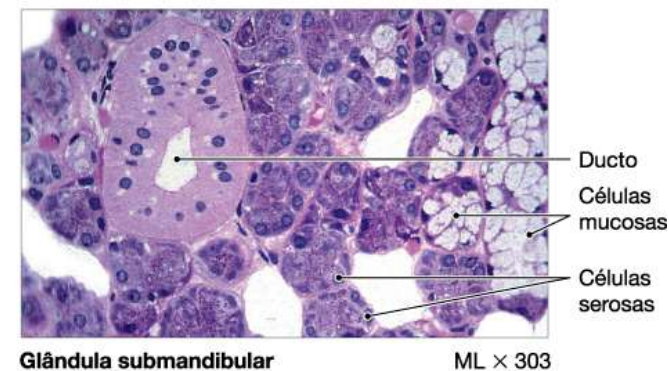


Figura 25.6 As glândulas salivares maiores.

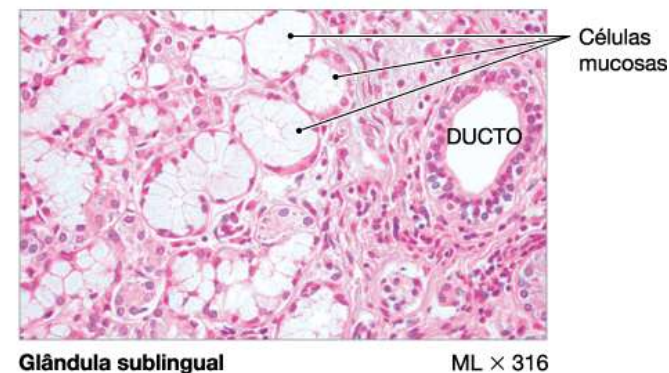
(a) Vista lateral, mostrando as posições relativas das glândulas salivares maiores e dos ductos no lado esquerdo da cabeça. Grande parte da metade esquerda do corpo e do ramo da mandíbula foi removida. Para as posições dos ductos dentro da cavidade oral, veja a Figura 25.5. (b) Detalhes histológicos das glândulas salivares parótida, submandibular e sublingual. A parótida produz saliva rica em enzimas. Esta glândula é dominada por células secretoras serosas. A glândula submandibular produz saliva contendo enzimas e mucinas e contém células secretoras serosas e mucosas. A glândula sublingual produz saliva rica em mucinas. Esta glândula é dominada por células secretoras mucosas.



Glândula parótida ML × 316



Glândula submandibular ML × 303



Glândula sublingual ML × 316

(b) Histologia de glândula salivar

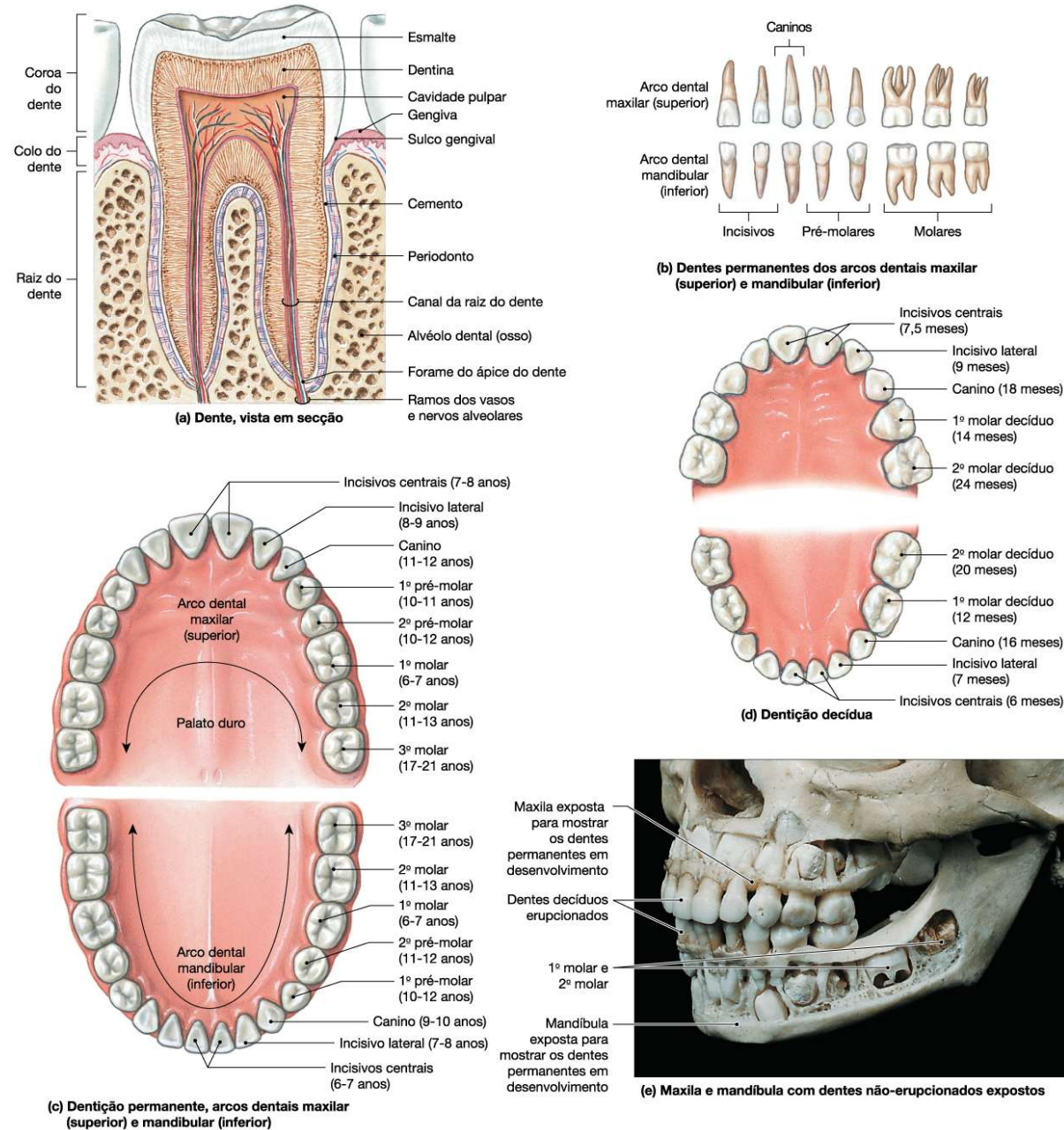
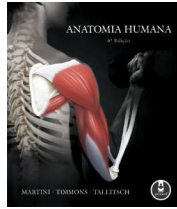


Figura 25.7 Dentes.

Os dentes realizam a mastigação do alimento. (a) Secção diagramática de um dente adulto. (b) Os dentes do adulto. (c) A orientação normal dos dentes no adulto. A variação etária normal para a erupção de cada dente é apresentada entre parênteses. (d) Os dentes deciduos com a idade de erupção dada em meses. (e) O crânio de uma criança de 4 anos de idade, com as maxilas e mandíbula seccionadas para expor os dentes permanentes ainda não irrompidos.

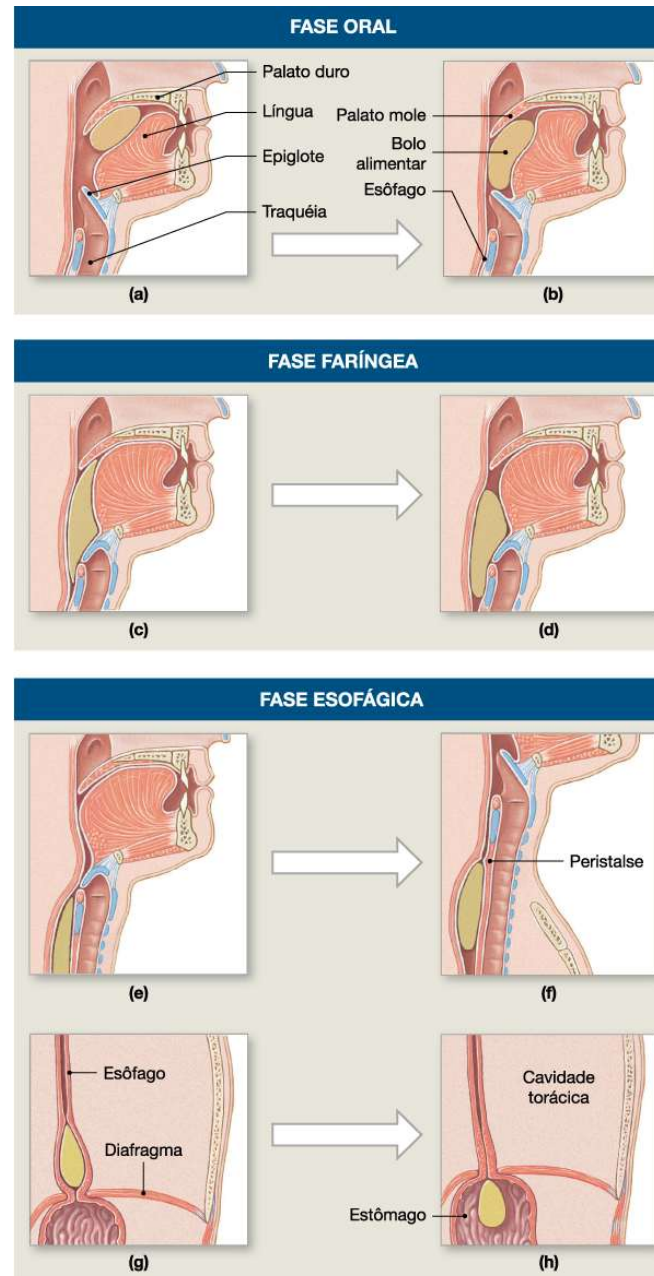
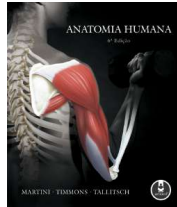


Figura 25.8 O processo da deglutição.

A sequência, baseada em uma série de imagens radiográficas, mostra os estágios da deglutição e a movimentação de materiais da boca ao estômago: (a, b) fase oral, (c, d) fase faríngea e (e-h) fase esofágica.

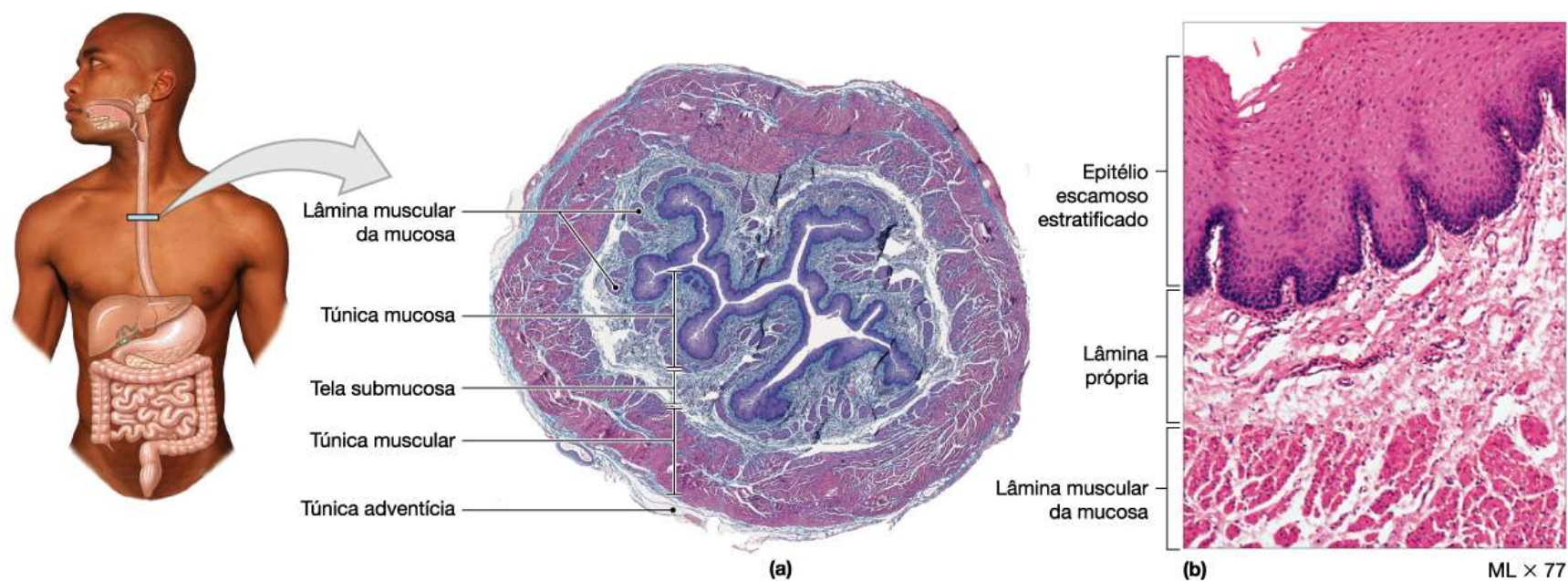
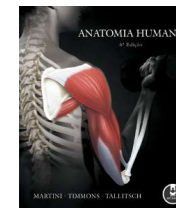
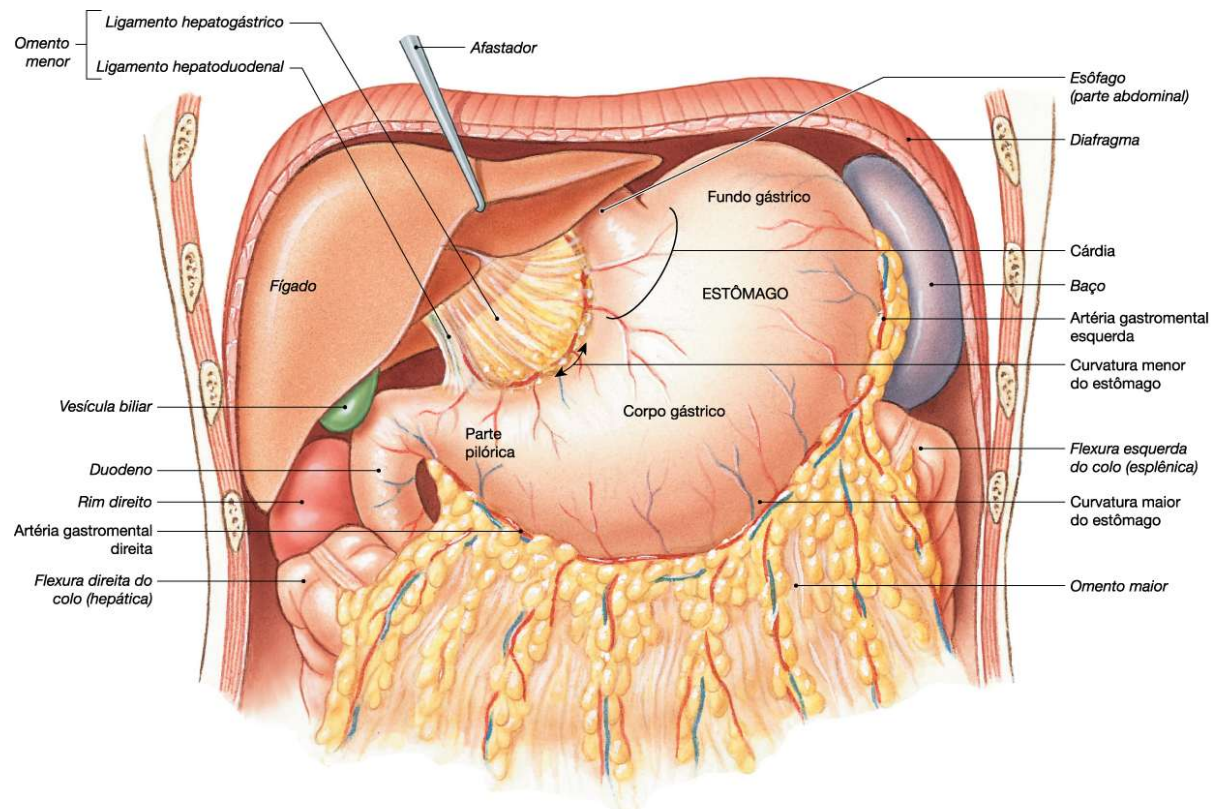
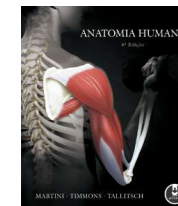
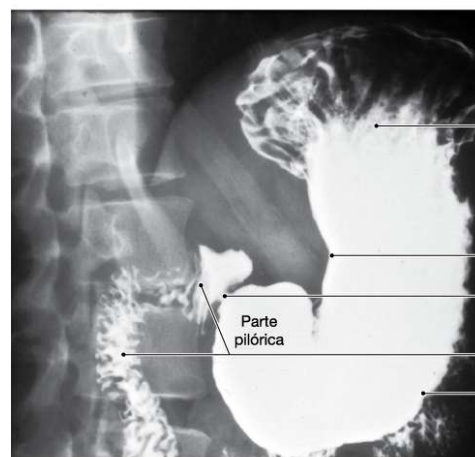


Figura 25.9 Histologia do esôfago.

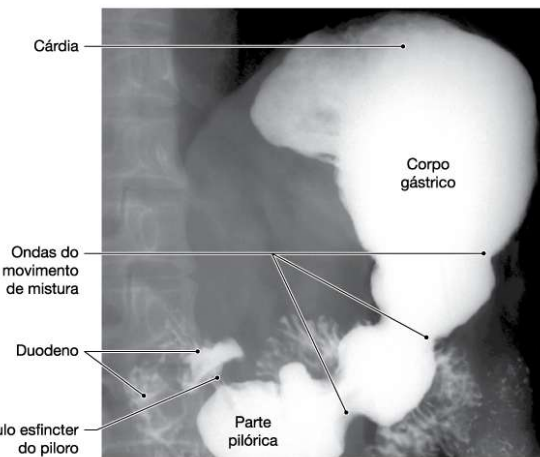
(a) Vista em baixa potência de uma secção transversal do esôfago. **(b)** Túnica mucosa esofágica.



(a) Estômago, vista anterior



(b) Radiografia, estômago e duodeno



(c) Radiografia, parte pilórica

Figura 25.10 O estômago e os omentos.

(a) Anatomia de superfície do estômago, mostrando vasos sanguíneos e relações com o fígado e os intestinos. (b) Radiografia do estômago e duodeno, após deglutição de solução de bário para aumentar o contraste. (c) Radiografia da parte pilórica e do duodeno, com o piloro controlando a passagem do conteúdo gástrico.

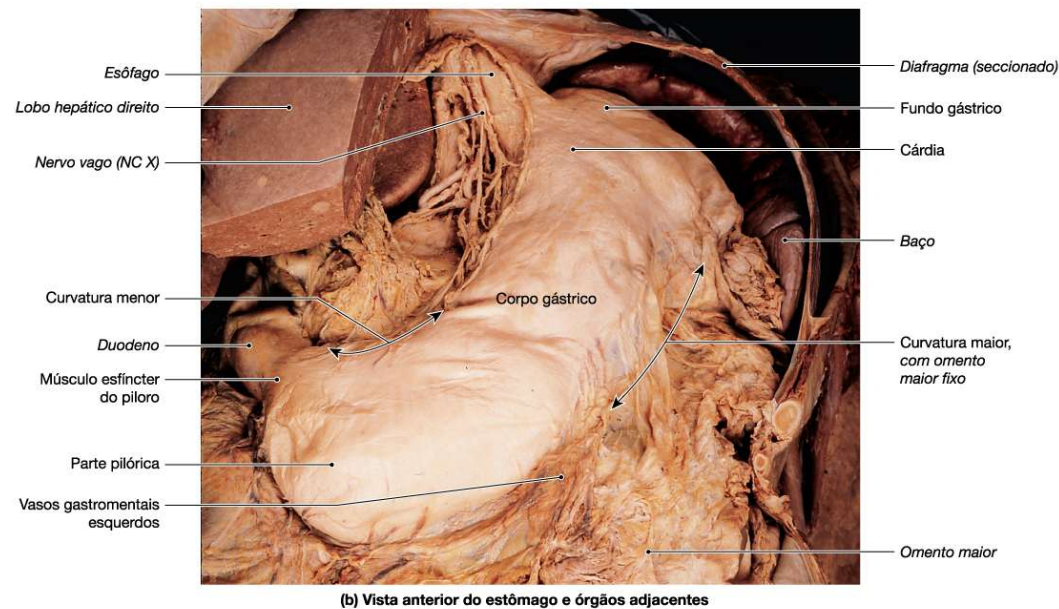
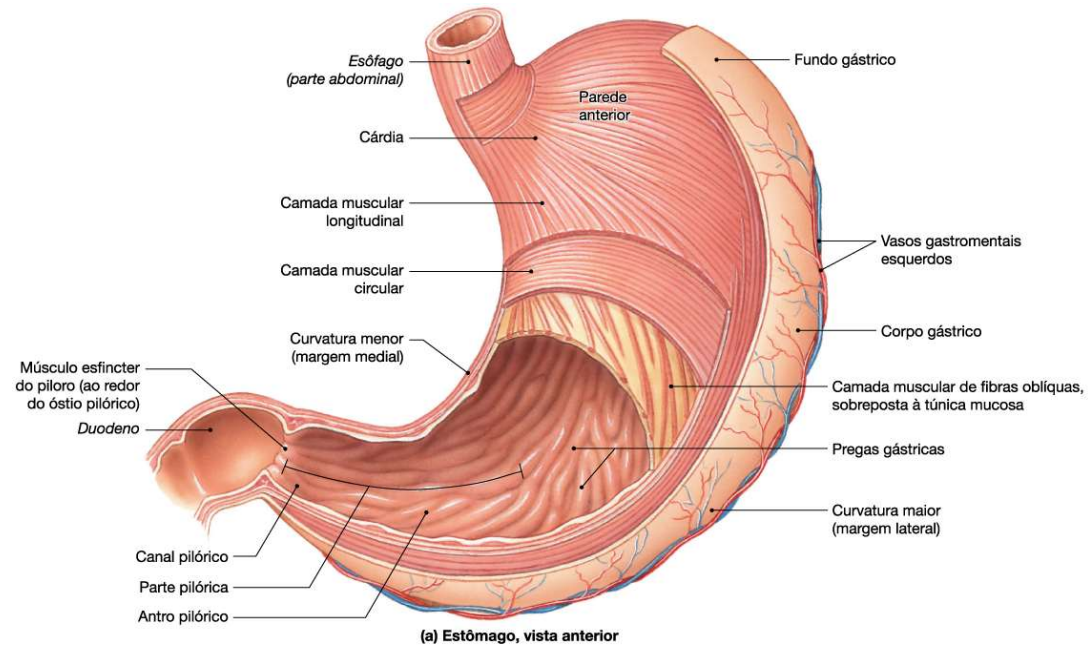
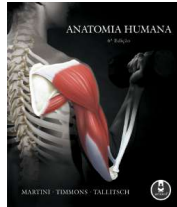


Figura 25.11 Anatomia macroscópica do estômago.

(a) Anatomias externa e interna do estômago. (b) Vista anterior da porção superior da cavidade abdominal após remoção do lobo hepático esquerdo e omento menor. Observe a posição e a orientação do estômago.

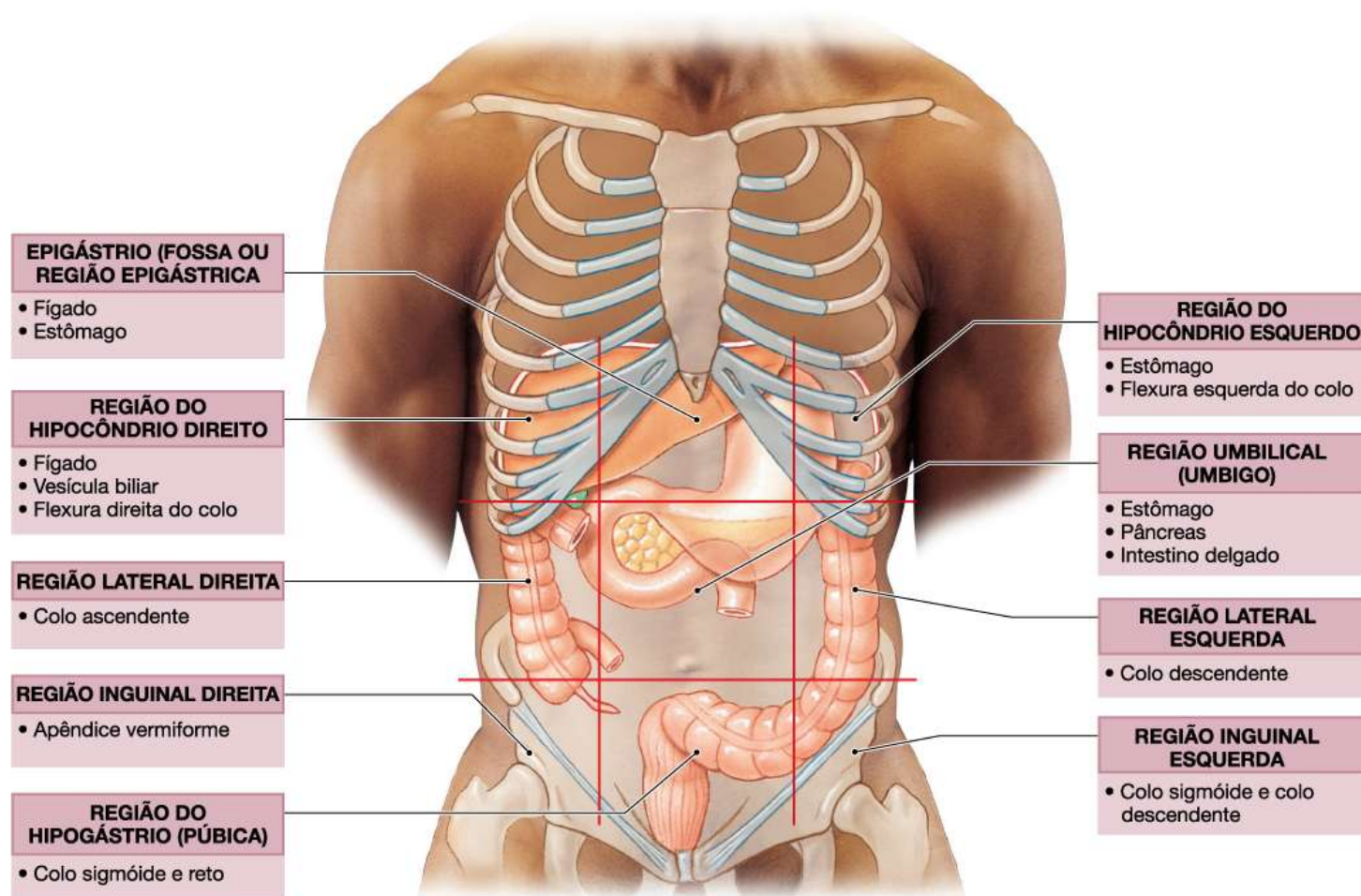
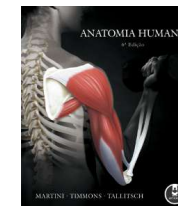
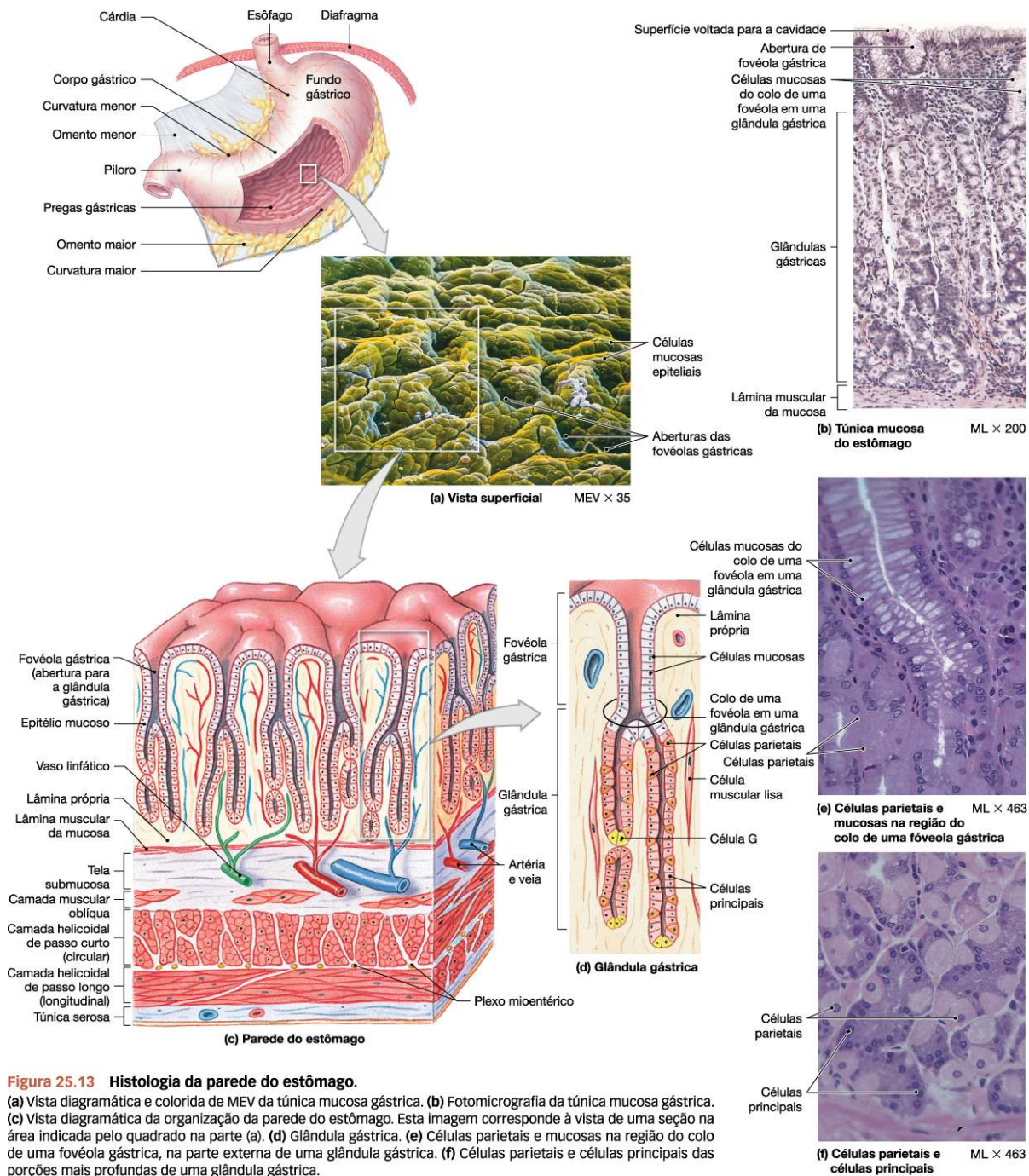
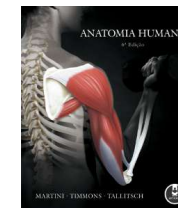


Figura 25.12 Regiões e planos do abdome.



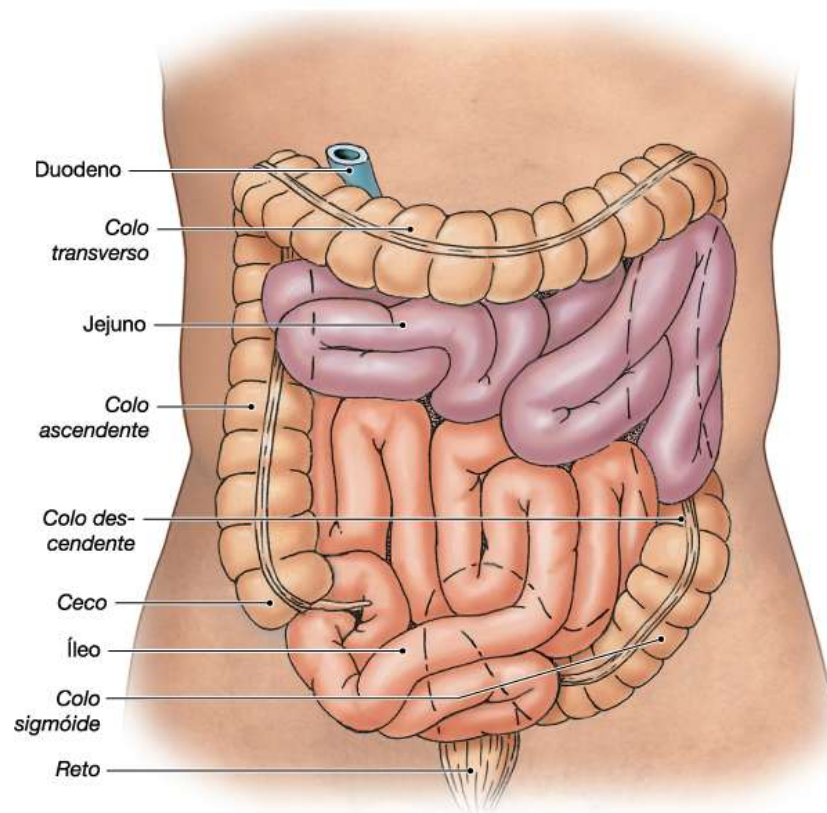


Figura 25.14 Partes do intestino delgado.

O código de cores indica os tamanhos relativos e as posições do duodeno, do jejuno e do íleo.

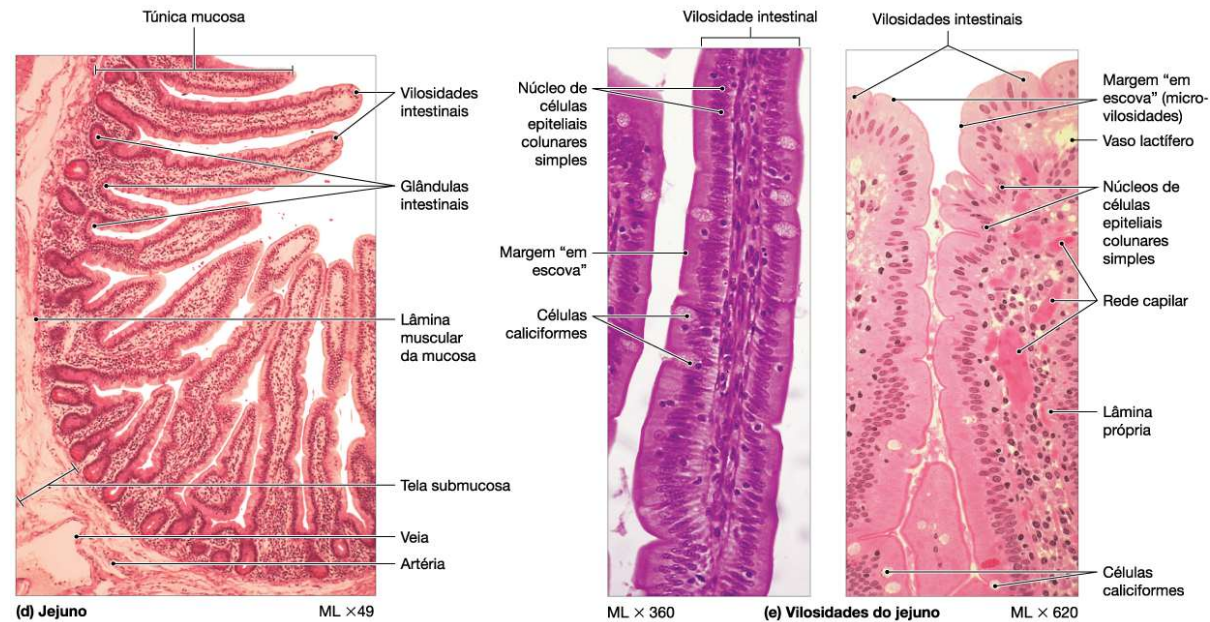
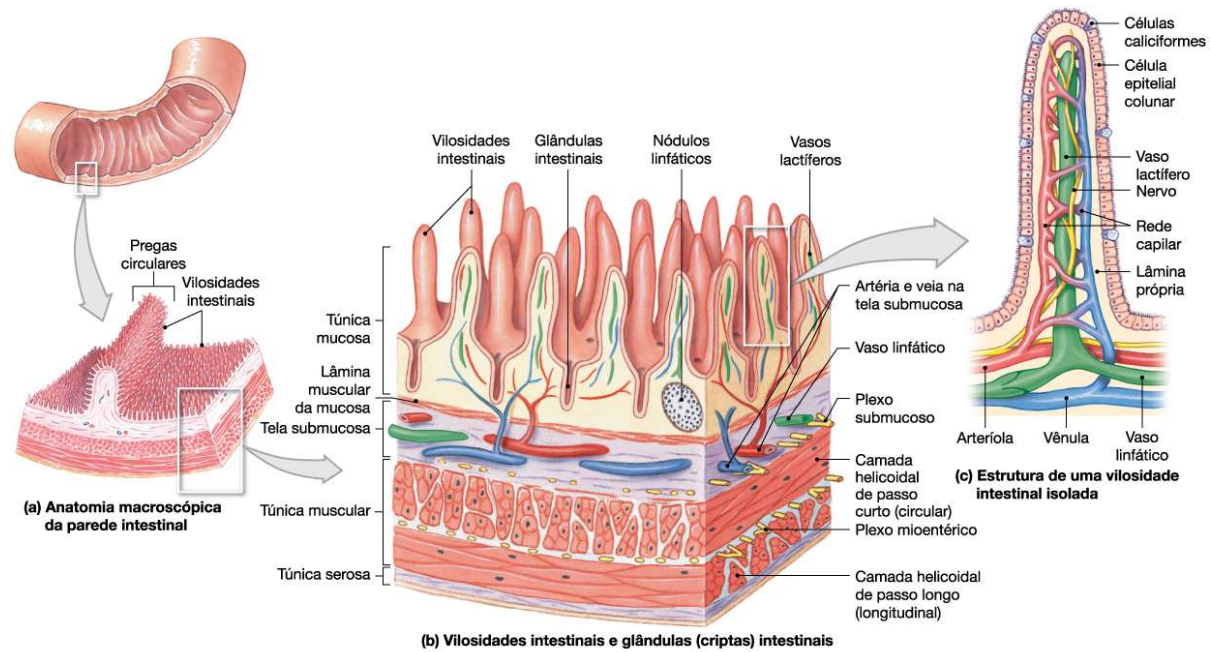


Figura 25.15 Histologia da parede intestinal.

(a) Características específicas do revestimento intestinal. (b) A organização das vilosidades e glândulas (criptas) intestinais. (c) Vista diagramática de uma única vilosidade, mostrando o suprimento de capilares e o suprimento linfático. (d) Vista panorâmica da parede do intestino delgado, mostrando a túnica mucosa com as vilosidades, pregas, tela submucosa e túnica muscular típicas. (e) Fotomicrografias das vilosidades do jejuno.

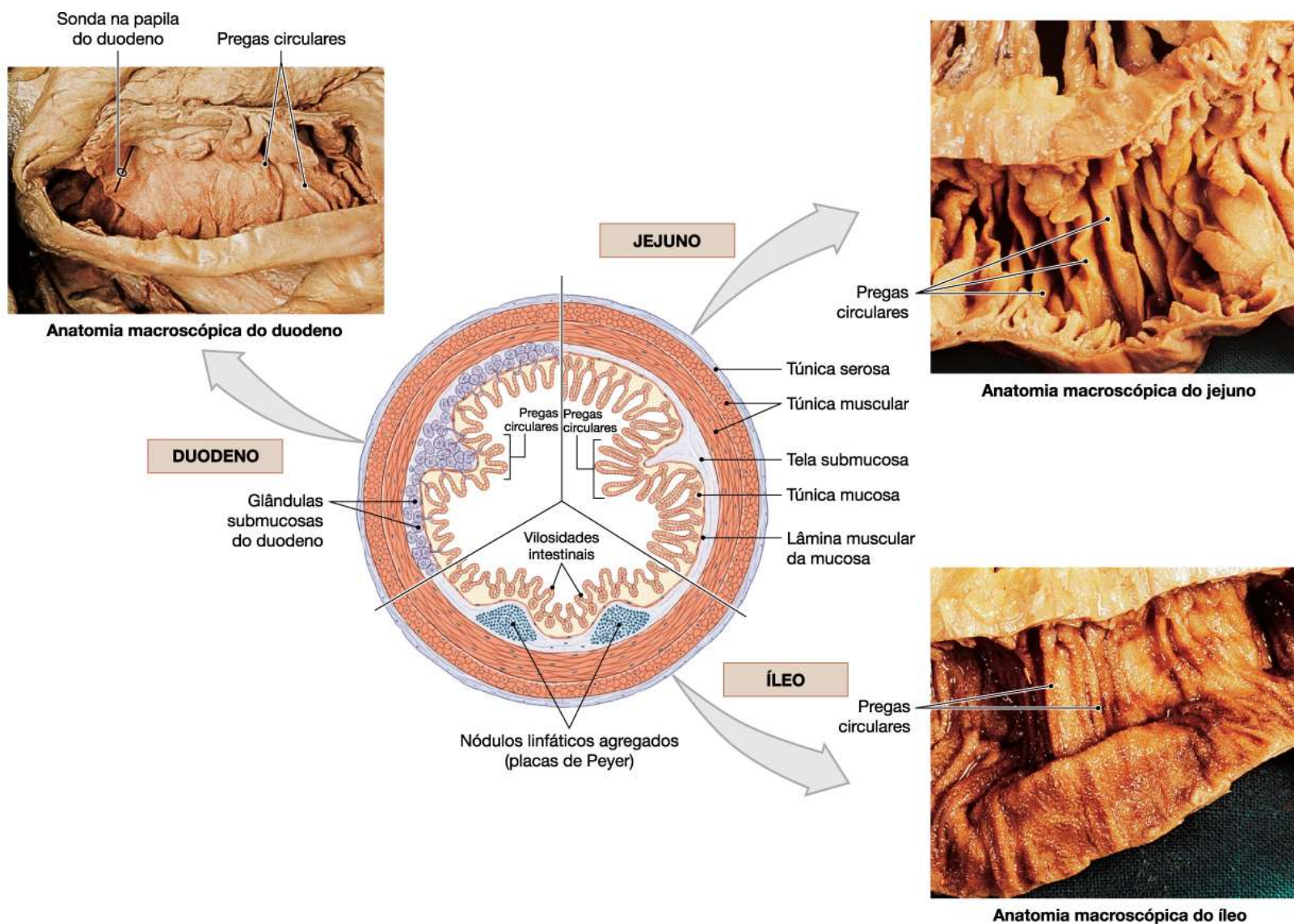


Figura 25.16 Partes do intestino delgado.

Vista diagramática ressaltando as figuras que diferenciam cada região do intestino delgado. O detalhe mostra a secção transversal no nível da papila do duodeno. As fotografias mostram a anatomia macroscópica do revestimento intestinal em cada parte do intestino delgado.

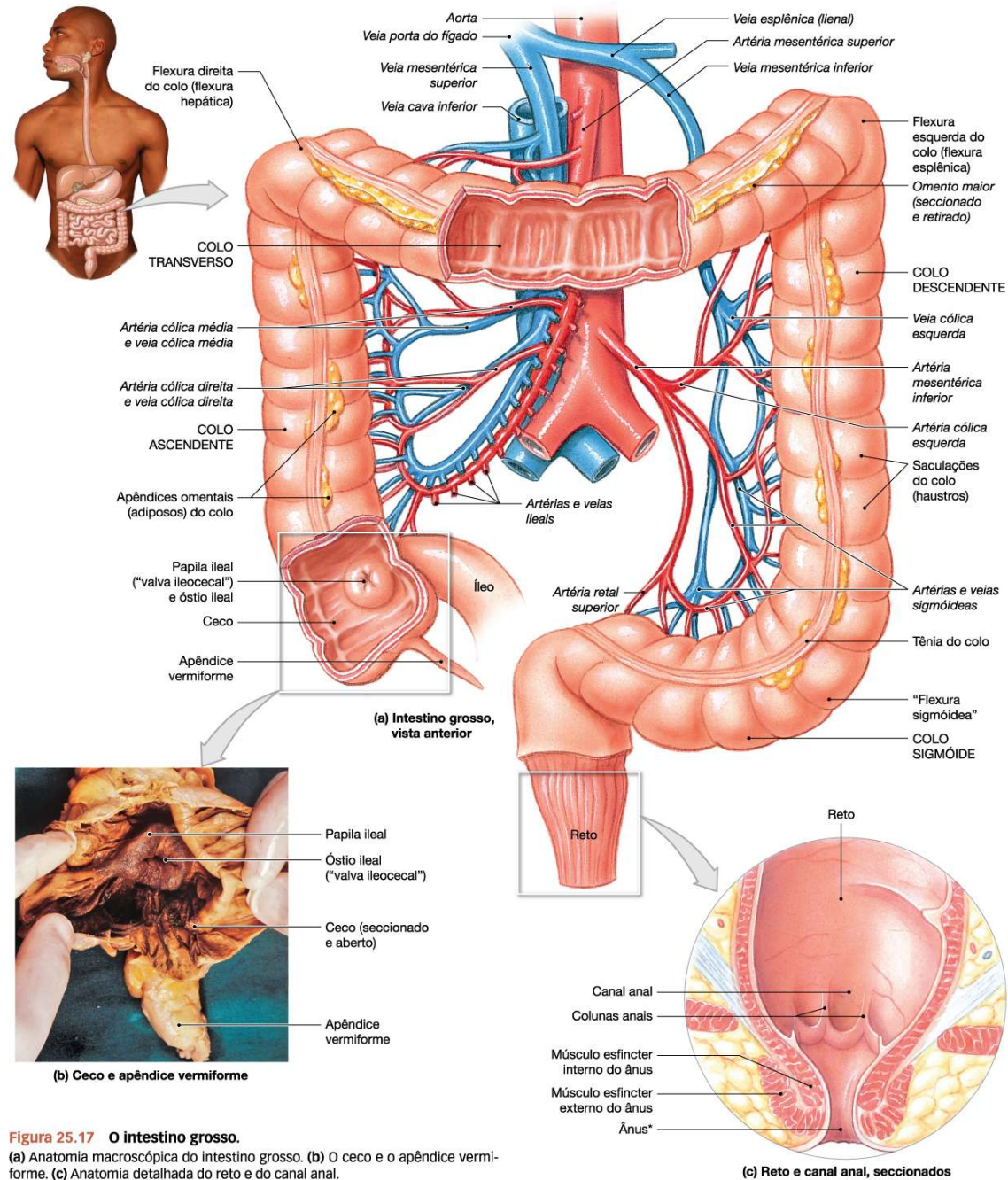


Figura 25.17 O intestino grosso.

(a) Anatomia macroscópica do intestino grosso. (b) O ceco e o apêndice vermiforme. (c) Anatomia detalhada do reto e do canal anal.

* N. de R.T. A linha está indicando a parte ectodérmica do canal anal e não propriamente o ânus, que corresponde à abertura do canal anal no meio externo.

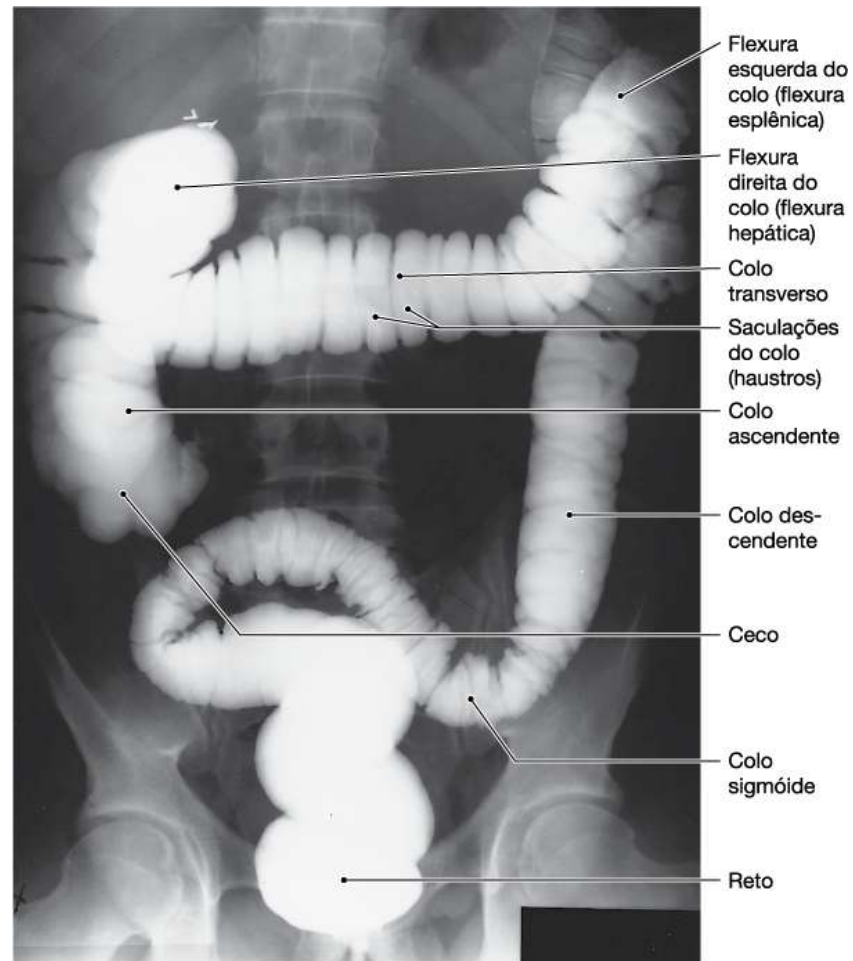
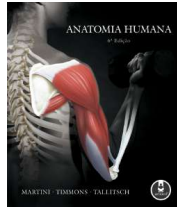


Figura 25.18 Radiografia ântero-posterior do colo.

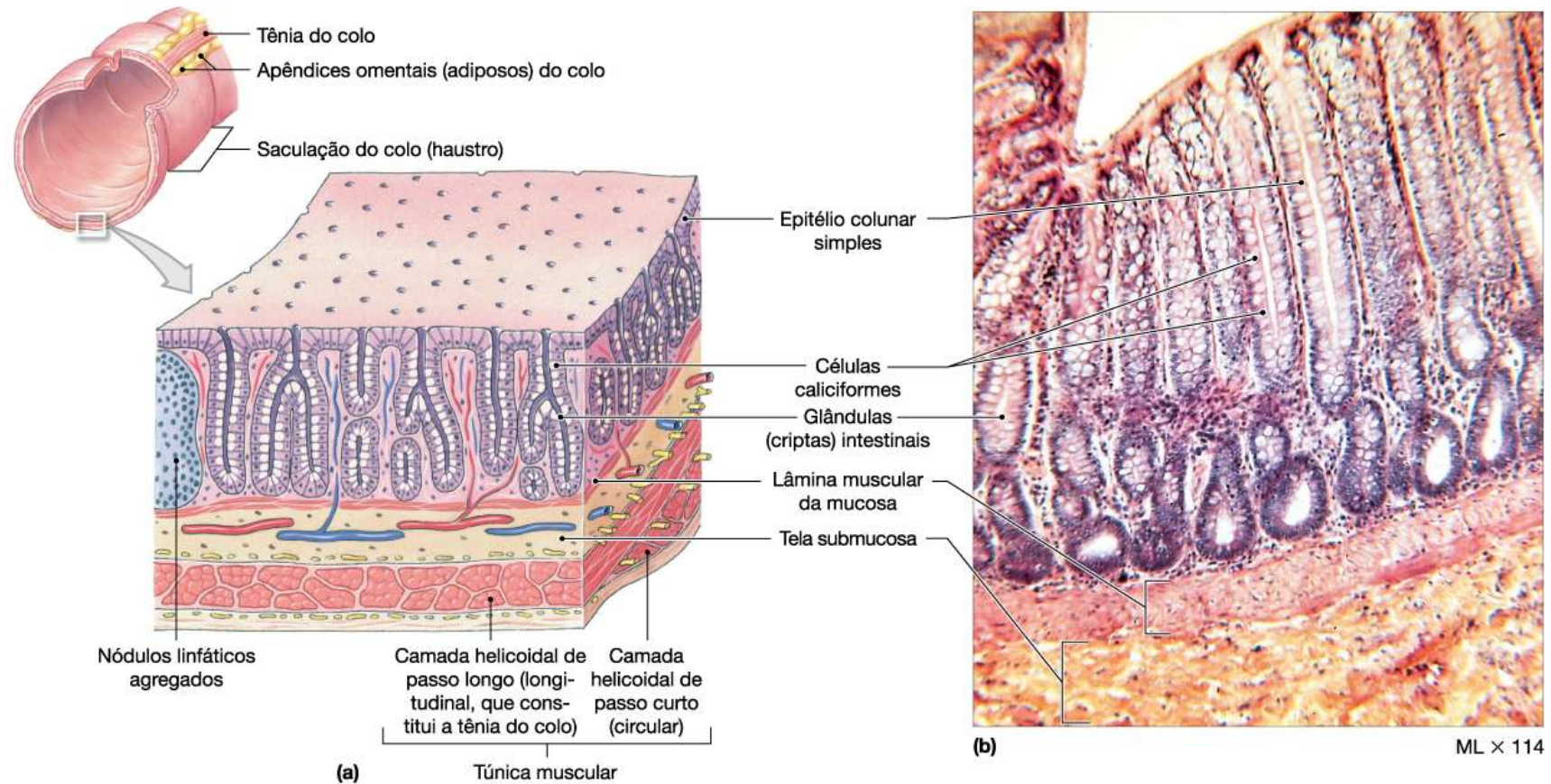


Figura 25.19 A parede do intestino grosso.

(a) Vista tridimensional e colonoscópica da parede do colo. **(b)** Histologia do colo, mostrando detalhes da túnica mucosa e da tela submucosa.

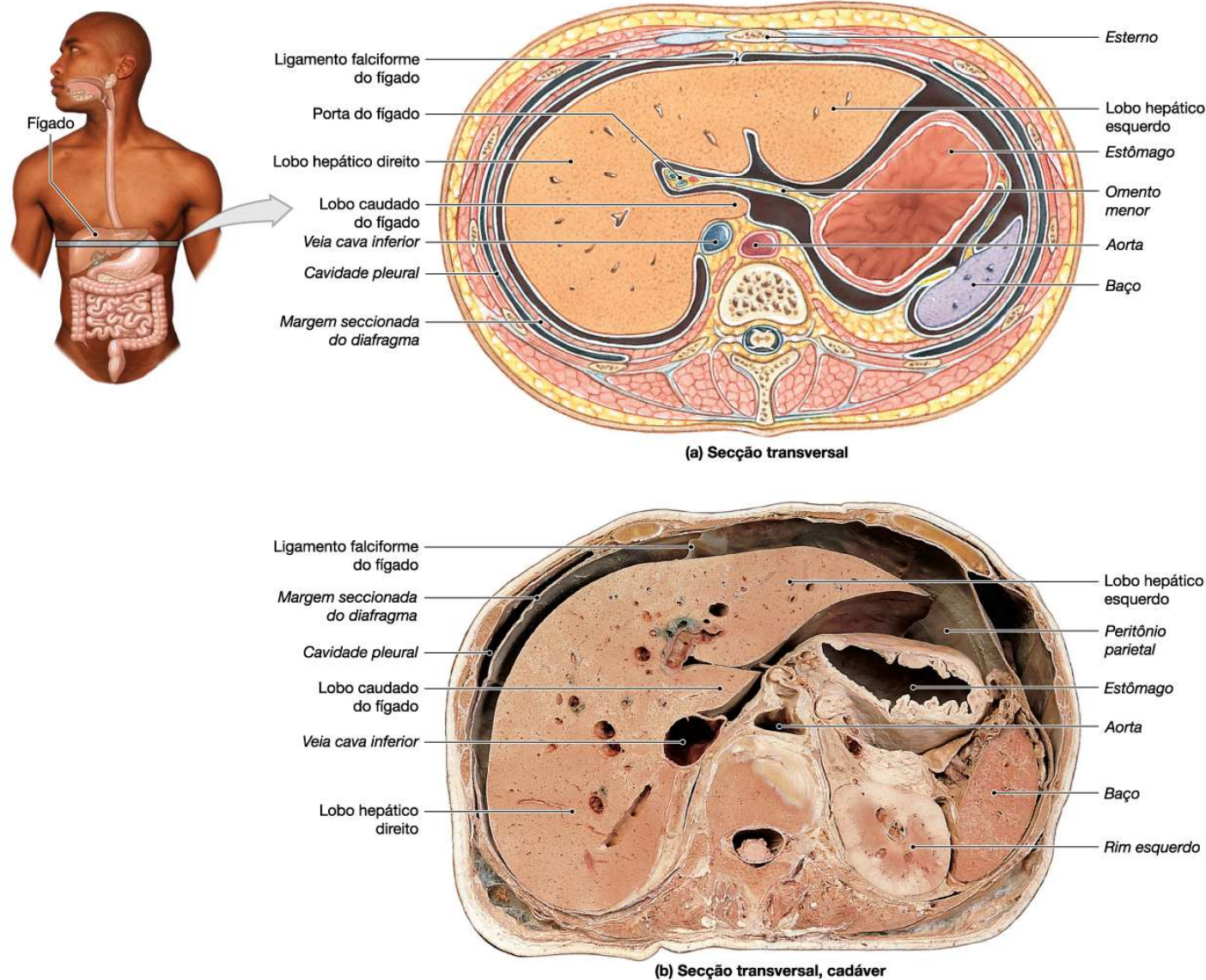
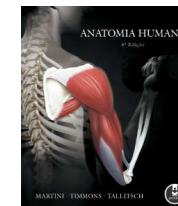
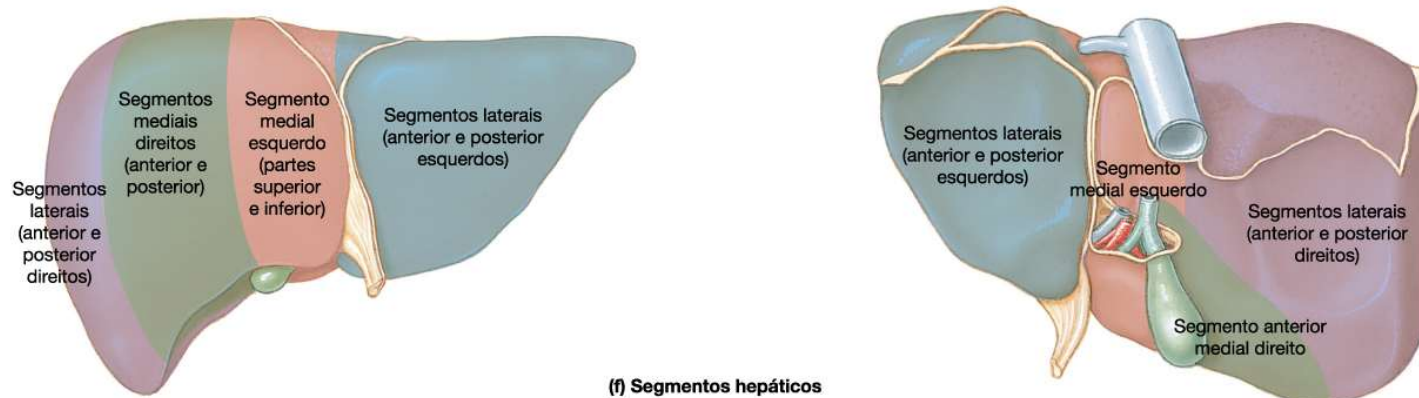
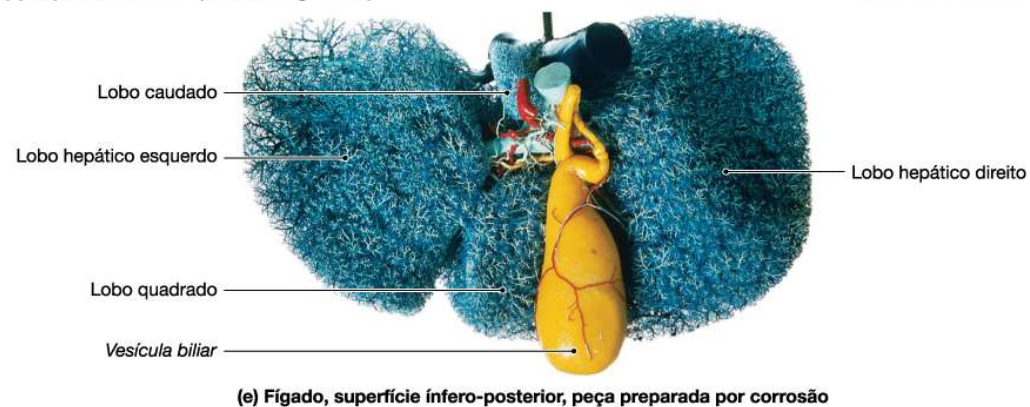
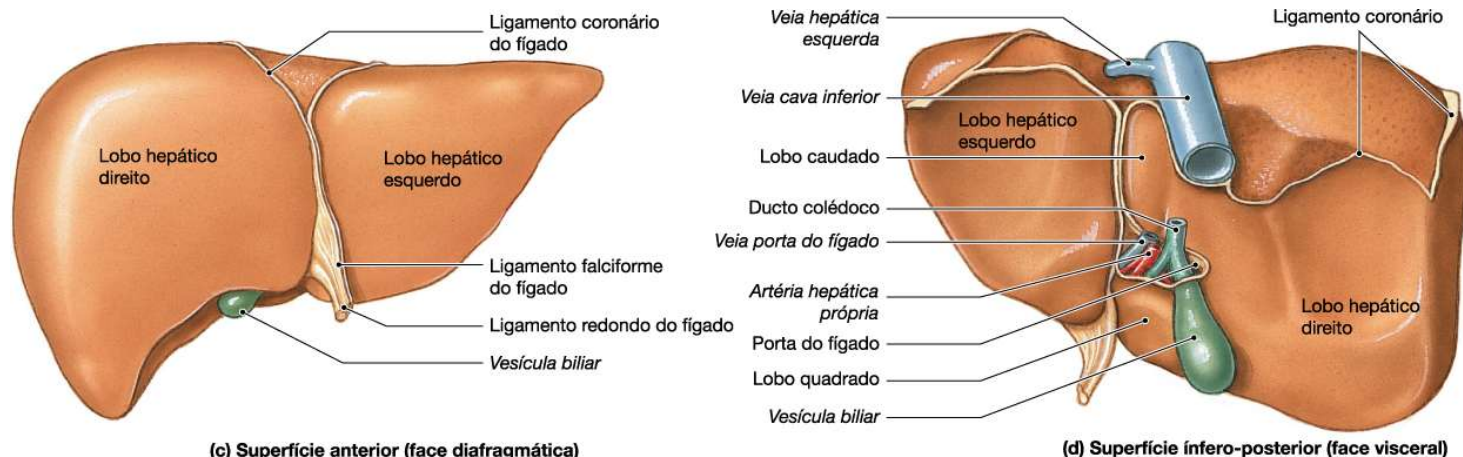


Figura 25.20 Anatomia do figado.

(a) Secção transversal no nível da região superior do abdome, mostrando a posição do figado em relação a outras vísceras. (b) Secção transversal no nível da região superior do abdome de um cadáver, mostrando estruturas ilustradas na parte (a). (c) Pontos de referência anatômica na superfície anterior do figado. (d) A superfície infero-posterior do figado. (e) Peça de figado preparado por corrosão, mostrando a vesícula biliar, os ductos bilíferos e os vasos sangüíneos associados, conforme vistos pela superfície infero-posterior. (f) Limites aproximados entre os principais segmentos hepáticos.



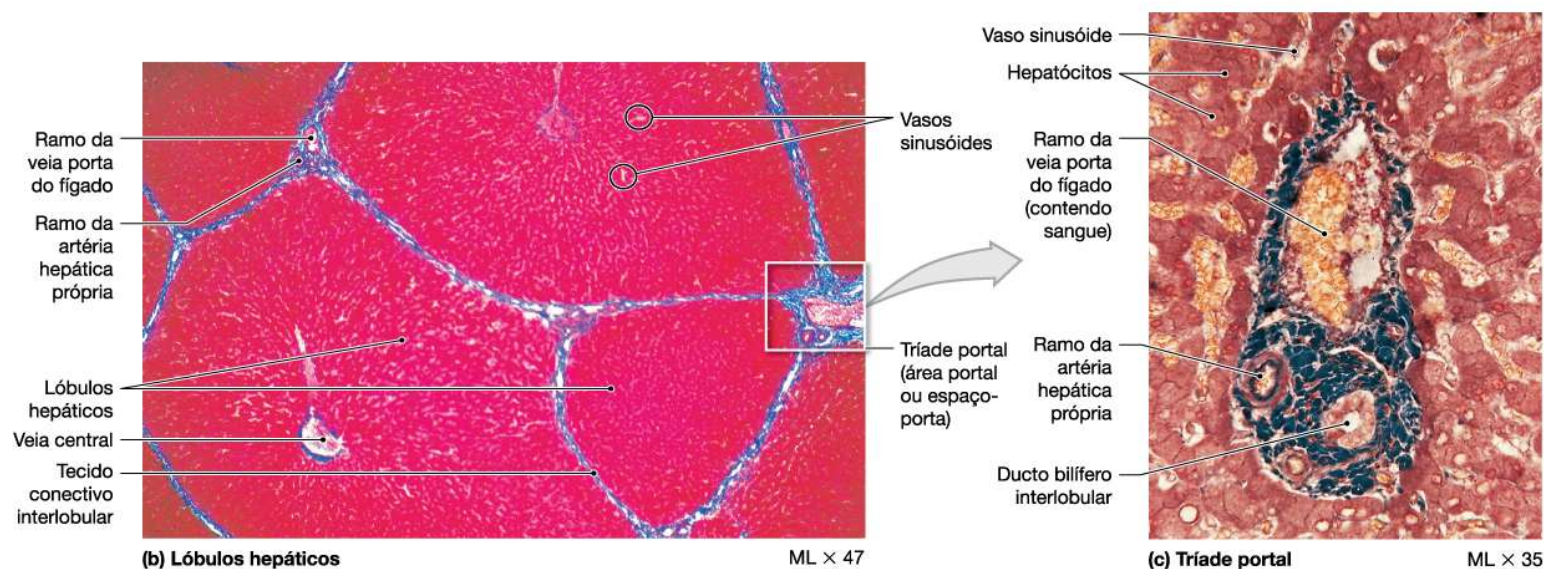
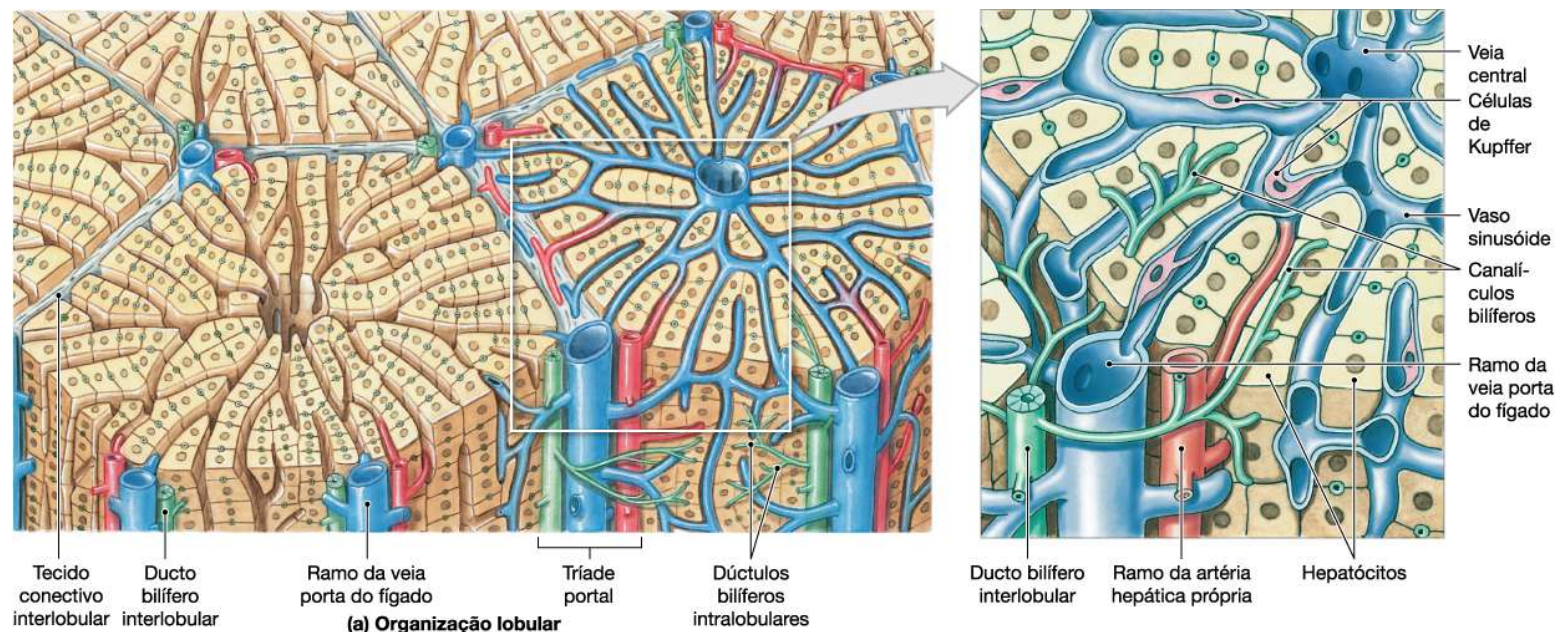
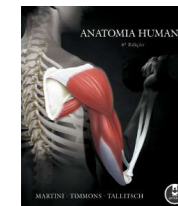


Figura 25.21 Histologia do fígado.

(a) Vista diagramática da organização lobular. **(b)** Micrografia de luz mostrando lóbulos hepáticos típicos de mamíferos. Lóbulos hepáticos humanos não apresentam limites distintos de tecido conectivo, dificultando a sua distinção em secções histológicas. **(c)** Micrografia de luz mostrando detalhe histológico de triade portal (área portal ou espaço-porta).

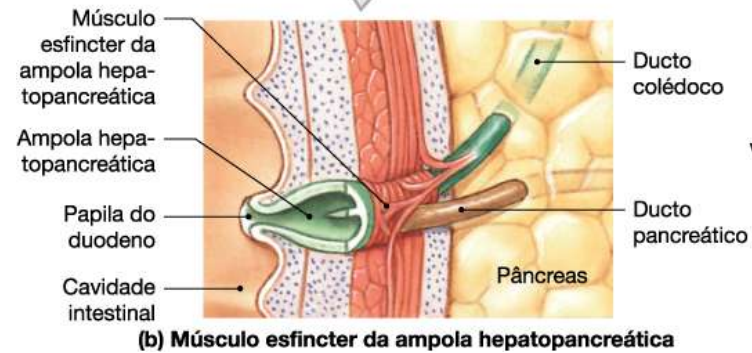
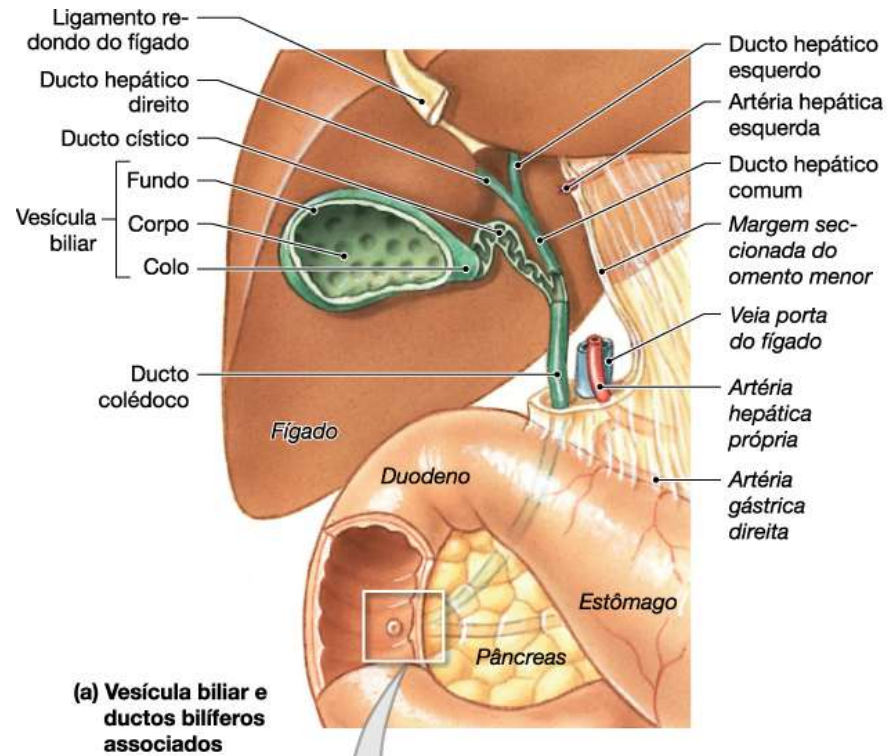
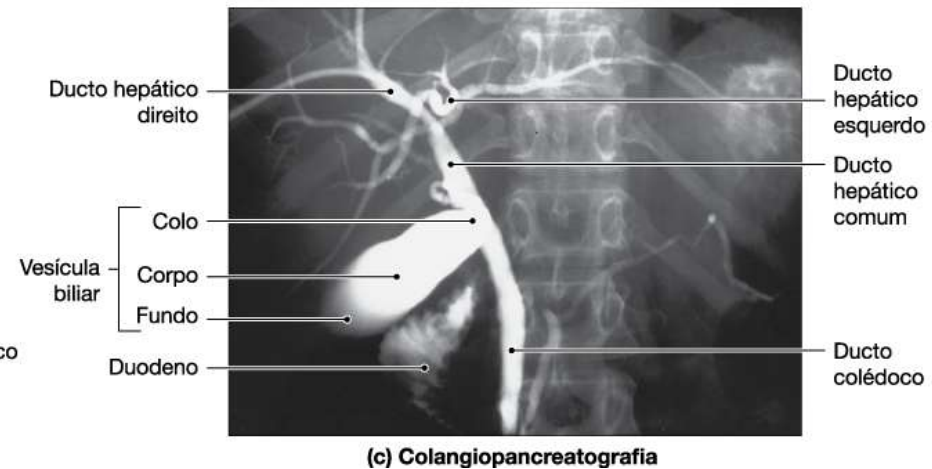


Figura 25.22 A vesícula biliar e os ductos bilíferos associados.

(a) Vista da superfície inferior do fígado, mostrando a posição da vesícula biliar e dos ductos que transportam bile desde o fígado até a vesícula biliar e o duodeno. (b) Parte do omento menor foi seccionada e removida para facilitar a visualização das relações entre o ducto colédoco, o ducto hepático comum e o ducto cístico. (c) Uma radiografia (colangiopancreatografia, vista ântero-posterior) da vesícula biliar e dos ductos bilíferos associados.



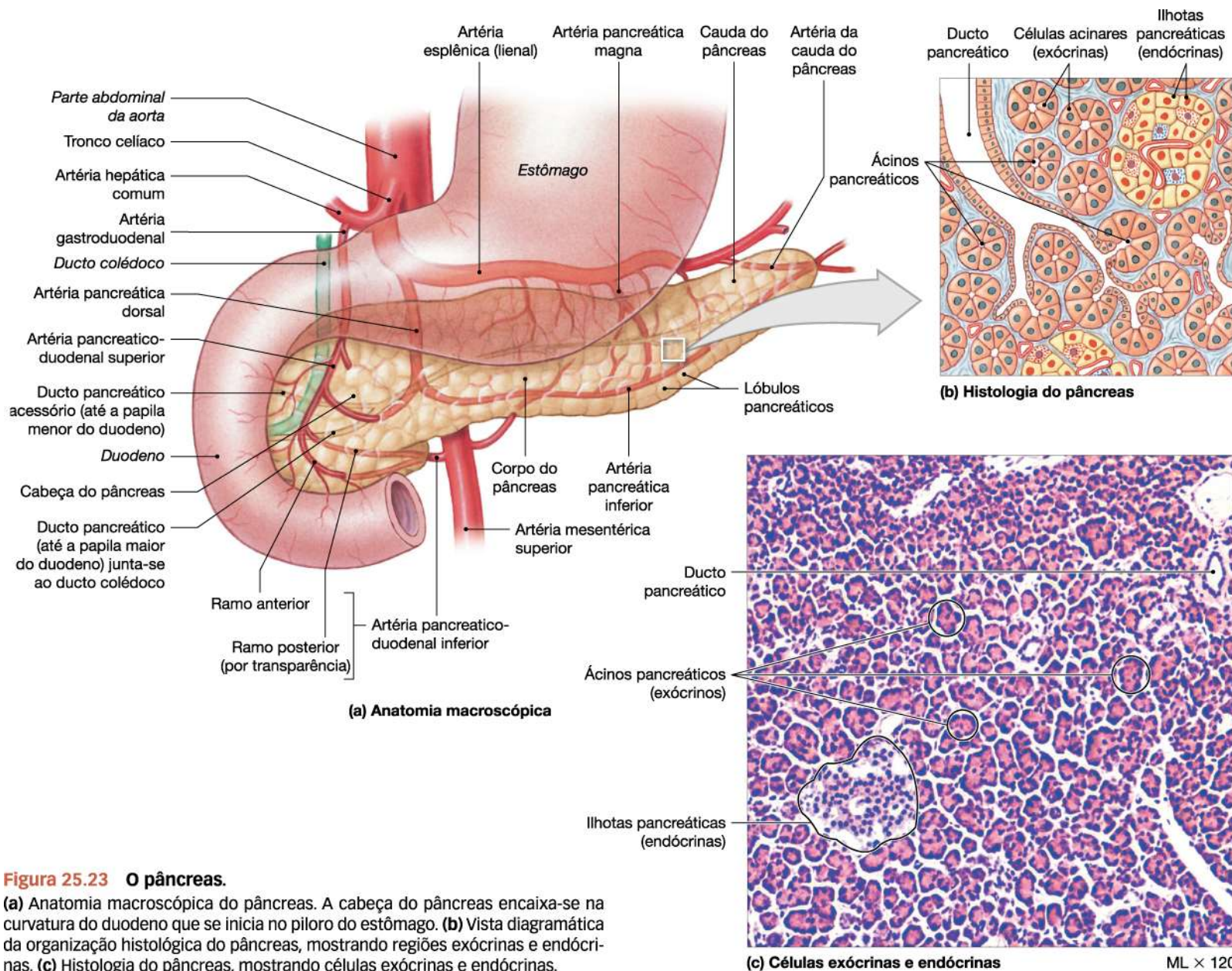
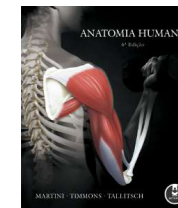


Figura 25.23 O pâncreas.

(a) Anatomia macroscópica do pâncreas. A cabeça do pâncreas encaixa-se na curvatura do duodeno que se inicia no píloro do estômago. **(b)** Vista diagramática da organização histológica do pâncreas, mostrando regiões exócrinas e endócrinas. **(c)** Histologia do pâncreas, mostrando células exócrinas e endócrinas.

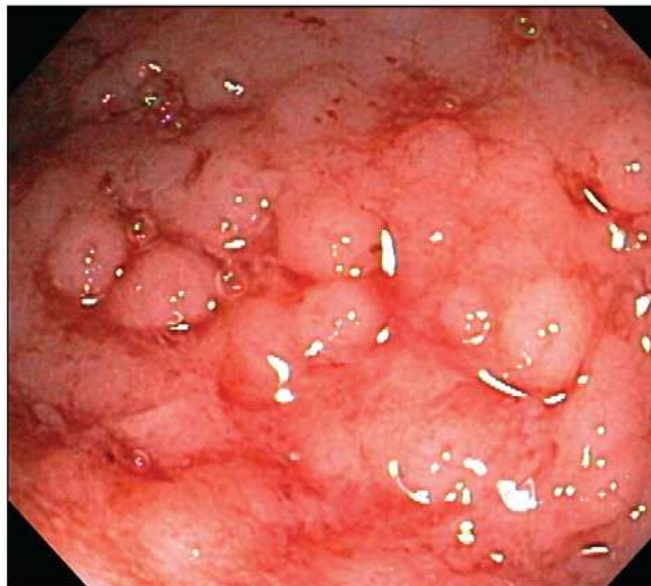
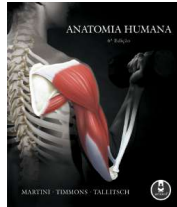


Figura 25.24 Inflamação do colo, conforme visto pela colonoscopia.